

Ziel und Zweck:

Übergeordnetes Ziel ist es, der Entstehung sowie der Chronifizierung von Schmerzen und schmerzbedingten Krisen vorzubeugen, Schmerzen zu beseitigen oder zu einer akzeptablen Schmerzsituation und zu Erhalt oder Erreichen einer bestmöglichen Lebensqualität und Funktionsfähigkeit beizutragen.

Grundsätzlich kann beim Vorliegen von Schmerzen zwischen einer stabilen und instabilen Schmerzsituation unterschieden werden. Eine **Akutschmerzsituation** ist grundsätzlich als instabil zu betrachten. In ihr besteht das Ziel darin, Schmerzen schnellstmöglich zu beseitigen oder auf ein subjektiv akzeptables Maß zu reduzieren und somit zu stabilisieren. Menschen mit akuten oder zu erwartenden Schmerzen soll durch ein angemessenes Schmerzmanagement unnötiges Leid erspart sowie einer Chronifizierung von Schmerzen vorgebeugt werden.

Bei Vorliegen **chronischer Schmerzen** steht anders als die Schmerzfreiheit bei akuten Schmerzen die Stabilität einer Schmerzsituation und die Ausrichtung an den Selbstmanagementkompetenzen des Betroffenen im Vordergrund. Handelt es sich um einen Menschen mit stark eingeschränkten Selbstmanagementkompetenzen, muss die Schmerzsituationsbeurteilung anhand von Verhaltensweisen und in enger Abstimmung mit pflegenden Angehörigen und dem multiprofessionellen Team erfolgen. Dies gilt für alle alten oder kognitiv eingeschränkten Menschen.

Eine **stabile** Schmerzsituation besteht demnach, wenn der Mensch seine Schmerzsituation subjektiv als akzeptabel und nicht veränderungsbedürftig erlebt und Zielkriterien für Stabilität sich konkret an seiner Lebenswelt orientieren und mit ihm ausgehandelt wurden.

Eine **instabile** Schmerzsituation liegt vor, wenn die Schmerzlinderung dauerhaft keine akzeptable Situation erzeugt und gesundheits- oder alltagsbezogene Krisen auftreten, die zu einer Einbuße an Lebensqualität, Funktionalität oder sozialer Teilhabe führen. Dies kann auch als schleichender Prozess auftreten.

Anwendungsbereich:

Zielgruppe dieses Expertenstandards sind Menschen mit akuten, chronischen oder zu erwartenden Schmerzen in allen pflegerischen Settings.

Anwender dieses Expertenstandards sind Pflegefachkräfte ohne spezielle Weiterbildung im Schmerzmanagement. Sind für die Durchführung spezielle Kompetenzen im pflegerischen Schmerzmanagement nötig, wird dies ausgewiesen.

Sollten die Anforderungen, die eine bestimmte Erkrankung mit sich bringt, das Fachwissen einer Pflegefachkraft übersteigen, wird ein pflegerischer Fachexperte hinzugezogen. Dies kann sowohl eine interne als auch externe Fachkraft sein.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	1	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle GmbH	Standard Schmerzmanagement	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

Ziel und Zweck:

Übergeordnetes Ziel ist es, der Entstehung sowie der Chronifizierung von Schmerzen und schmerzbedingten Krisen vorzubeugen, Schmerzen zu beseitigen oder zu einer akzeptablen Schmerzsituation und zu Erhalt oder Erreichen einer bestmöglichen Lebensqualität und Funktionsfähigkeit beizutragen.

Grundsätzlich kann beim Vorliegen von Schmerzen zwischen einer stabilen und instabilen Schmerzsituation unterschieden werden. Eine **Akutschmerzsituation** ist grundsätzlich als instabil zu betrachten. In ihr besteht das Ziel darin, Schmerzen schnellstmöglich zu beseitigen oder auf ein subjektiv akzeptables Maß zu reduzieren und somit zu stabilisieren. Menschen mit akuten oder zu erwartenden Schmerzen soll durch ein angemessenes Schmerzmanagement unnötiges Leid erspart sowie einer Chronifizierung von Schmerzen vorgebeugt werden.

Bei Vorliegen **chronischer Schmerzen** steht anders als die Schmerzfreiheit bei akuten Schmerzen die Stabilität einer Schmerzsituation und die Ausrichtung an den Selbstmanagementkompetenzen des Betroffenen im Vordergrund. Handelt es sich um einen Menschen mit stark eingeschränkten Selbstmanagementkompetenzen, muss die Schmerzsituationsbeurteilung anhand von Verhaltensweisen und in enger Abstimmung mit pflegenden Angehörigen und dem multiprofessionellen Team erfolgen. Dies gilt für alle alten oder kognitiv eingeschränkten Menschen.

Eine **stabile** Schmerzsituation besteht demnach, wenn der Mensch seine Schmerzsituation subjektiv als akzeptabel und nicht veränderungsbedürftig erlebt und Zielkriterien für Stabilität sich konkret an seiner Lebenswelt orientieren und mit ihm ausgehandelt wurden.

Eine **instabile** Schmerzsituation liegt vor, wenn die Schmerzlinderung dauerhaft keine akzeptable Situation erzeugt und gesundheits- oder alltagsbezogene Krisen auftreten, die zu einer Einbuße an Lebensqualität, Funktionalität oder sozialer Teilhabe führen. Dies kann auch als schleichender Prozess auftreten.

Anwendungsbereich:

Zielgruppe dieses Expertenstandards sind Menschen mit akuten, chronischen oder zu erwartenden Schmerzen in allen pflegerischen Settings.

Anwender dieses Expertenstandards sind Pflegefachkräfte ohne spezielle Weiterbildung im Schmerzmanagement. Sind für die Durchführung spezielle Kompetenzen im pflegerischen Schmerzmanagement nötig, wird dies ausgewiesen.

Sollten die Anforderungen, die eine bestimmte Erkrankung mit sich bringt, das Fachwissen einer Pflegefachkraft übersteigen, wird ein pflegerischer Fachexperte hinzugezogen. Dies kann sowohl eine interne als auch externe Fachkraft sein.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	1	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle GmbH	Standard Schmerzmanagement	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

Definition

Akuter Schmerz ist ein plötzlich auftretender und einen begrenzten Zeitraum andauernder Schmerz, der in einem offensichtlichen und direkten Zusammenhang mit einer Gewebe- und Organschädigung steht. Er nimmt eine lebenserhaltende Alarm- und Schutzfunktion ein, die sich auch durch physiologische Begleiterscheinungen zeigt. Dazu gehören u. a. der Anstieg des Blutdrucks, des Pulses und der Atemfrequenz. Eine Akutschmerzsituation ist grundsätzlich als instabil zu betrachten.

Von **chronischem Schmerz** spricht man, wenn er länger als drei Monate anhält. Wichtig ist, dass dies nicht im Sinne eines exakten Zeitpunktes verstanden wird, sondern der Übergang von akutem zu chronischem Schmerz als fließend und am individuellen Schmerz- und Krankheitserleben ausgerichtet erkannt wird. Eine kontinuierliche Betrachtung der Kriterien ‚Intensität der Pathologie‘ und ‚Dauer‘ sowie das wechselseitige und dynamische Zusammenspiel physiologischer und psychologischer Faktoren werden als wichtige Besonderheit der Chronifizierung identifiziert.

Die systematische Schmerzeinschätzung ist Voraussetzung für ein effektives Schmerzmanagement.

Sie beinhaltet die Durchführung eines Screenings und bei vorhandenen Schmerzen eines Assessments sowie je nach Schmerzart und Schmerztherapie auch die Verlaufserfassung bzw. Monitoring von Schmerzen.

Eine stabile Schmerzsituation bei chronischen Schmerzen ist gekennzeichnet durch eine bestehende medikamentöse und nicht-medikamentöse Therapie auf Basis eines Behandlungsplans, der im Idealfall mit dem Menschen mit Schmerzen entwickelt wurde, von ihm akzeptiert wird und aus professioneller Sicht angemessen ist.

Einschätzung durch die Pflegefachkraft

Dazu gehört zum einen das Wissen darüber, wie Schmerzen entstehen und wie sie kommuniziert werden, sowohl bei auskunftsfähigen als auch bei Menschen, die ihre Schmerzen nicht sprachlich äußern können. Zum anderen muss die Pflegefachkraft über die Fähigkeiten und eine professionelle Haltung verfügen, bei jedem Menschen mit Schmerzen oder zu erwartenden Schmerzen in jeder Situation eine pflegerische Einschätzung vorzunehmen und die jeweils erforderlichen Maßnahmen auszuwählen und anzuwenden.

Die Pflegefachkraft besitzt die Kompetenzen, die es ihr ermöglichen, Schmerzen erkennen, einschätzen und differenzieren zu können. Sie berücksichtigt dabei die bio-psycho-soziale und spirituelle Dimension des Schmerzes. Ihr ist bekannt, dass Schmerz ein subjektives Erleben ist und die Selbsteinschätzung im Assessment Vorrang vor der Fremdeinschätzung hat.

Die Pflegefachkraft schätzt beim Schmerzassessment folgende Kriterien ein:

- in welchem Ausmaß ist der Mensch situativ dazu in der Lage, sprachlich Auskunft zu seinen Schmerzen zu geben,
- kulturelle und soziale Faktoren,
- Risikofaktoren für das Auftreten von Schmerzen,
- verbale, nonverbale, verhaltensbezogene und physiologische Anzeichen für Schmerzen

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	2	Verw./MA

Die Pflegefachkraft erkennt ob der Mensch **akute oder chronische Schmerzen** hat.

Sie erkennt, ob es sich um eine stabile oder instabile Schmerzsituation handelt.

Von einer **stabilen** Schmerzsituation kann zudem gesprochen werden, wenn:

- eine Schmerzsituation ohne Überschreiten des individuellen Schmerzmaßes vorliegt oder die Fremdeinschätzung und die damit verbundene Analyse des Verhaltens bzw. der Verhaltensveränderungen keinen Verdacht auf Schmerzen nahelegen,
- eine abhängig von der gesundheitlichen Situation akzeptable Funktionalität und Mobilität vorliegt,
- für mögliche Krisen und Komplikationen Strategien zur Bewältigung bekannt sind,
- keine unerwünschten Nebenwirkungen der Therapien und Komplikationen der Erkrankung auftreten.

Von einer **instabilen** Schmerzsituation bei chronischen Schmerzen kann gesprochen werden, wenn:

- die Schmerzsituation und -linderung dauerhaft nicht einer akzeptablen Situation entspricht,
- gesundheitsbezogene oder alltagsbezogene Krisen auftreten oder noch nicht wieder durch eine akzeptable Situation abgelöst wurden,
- Versorgungsbrüche entstehen, die nicht mit Hilfe von Selbstmanagementkompetenz, familiärer oder professioneller Unterstützung überbrückt werden können,
- Komplikationen mit der oder durch die Therapie oder deren Nebenwirkungen auftreten,
- durch die Schmerzsituation eine Einbuße an Lebensqualität, Funktionalität oder sozialer Teilhabe entstanden ist, die nicht mehr dem direkt geäußerten oder mutmaßlichen Willen des Menschen mit Schmerzen entspricht. Besonders der Prozess der langsamen Verschlechterung des Gesundheitszustandes fordert von Pflegefachkräften, eine regelmäßige kritische Reflektion der Schmerzsituation vorzunehmen.

Akute Schmerzen sollen den Menschen mit Schmerzen z. B. nicht in den Alltagsaktivitäten beeinträchtigen, da diese, werden sie nicht ausreichend behandelt, chronifizieren können.

Bei der Erfassung und Evaluation von akuten Schmerzen muss die Pflegefachkraft berücksichtigen, dass die Zielsetzung besteht, die Schmerzen zu beseitigen bzw. zumindest auf akzeptables Schmerz- maß zu reduzieren.

Gemeinsam mit dem Menschen mit Schmerzen und ggf. den Angehörigen oder anderen wichtigen Bezugspersonen muss die Pflegefachkraft besprechen, welche Faktoren bestehen, die Einfluss auf die Schmerzsituation haben.

Die pflegerische Schmerzeinschätzung beginnt mit dem pflegerischen Auftrag mit einem kurzen, situationsbezogenen Screening. Dabei wird zuerst geprüft ob Schmerzen vorliegen, vorliegen könnten oder mit hoher Wahrscheinlichkeit bald vorliegen werden. Nicht alle Menschen mit Schmerzen sprechen aktiv ihre Schmerzproblematik an oder sind dazu in der Lage. Es ist daher erforderlich, dass die Pflegefachkraft die Initiative ergreift und aktiv nach

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	3	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle GmbH	Standard Schmerzmanagement	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

Schmerzen fragt bzw. ihre klinische Beobachtung auf Veränderungen im Verhalten, der Funktionalität oder Alltagsfähigkeit richtet.

Liegen keine Schmerzen vor, wird das Screening in Rahmen der Evaluation des Pflegeprozesses sowie bei jeder Veränderung des Allgemeinzustands wiederholt. Die Pflegefachkraft kann auch ein auf den Menschen mit Schmerzen individuell abgestimmtes Intervall zur Wiederholung des Screenings festlegen.

Liegen akute Schmerzen vor, ist es erforderlich, zunächst für eine sofortige Schmerzreduktion zu sorgen, bevor weitere Schritte des Assessment folgen. Menschen mit starken Schmerzen sind nicht immer in der Lage, sich aktiv am Assessmentprozess zu beteiligen. Der behandelnde Arzt ist bei akuten Schmerzen sofort zu informieren, sofern im Behandlungsplan keine Schmerzmedikation für diesen speziellen Bedarfsfall verordnet ist

Das Assessment beinhaltet körperliche, soziale, psychische und spirituelle Faktoren und Informationen

zur aktuellen persönlichen Situation, da die Schmerzvorgeschichte inklusive der vorangegangenen Schmerzbehandlung und der kontextuellen Faktoren das Schmerzerleben der Betroffenen beeinflussen. Informationen über schmerzverursachende Erkrankungen und Ko- Morbiditäten gehören ebenso dazu wie die Bewältigungsstrategien des Menschen mit Schmerzen und die Reaktion auf therapeutische Maßnahmen.

Grundsätzlich gehört zum Assessment, eine Erfassung in Ruhe und bei Belastung oder Bewegung als Leitsymptom mittels standardisierter Skalen, NRS (numerische Ratingskala) und VAS (visuelle analog Skala> Smiley Skala) wenn nur Fremdeinschätzung möglich ist wird ECPA verwendet

- die zeitliche Dimension und das Auftreten, d.h. den Beginn, die Dauer der Schmerzen insgesamt und ggf. einzelner Episoden, sowie deren Varianten, Rhythmen und Verlaufsmuster,
- die Schmerzintensität und das individuell akzeptable Schmerzmaß,
- die Schmerzlokalisation(-en), Anzahl und Ausstrahlungsmuster, z. B. anhand eines Körperschemas,
- die Schmerzqualität, z. B. stechend, pochend, brennend, elektrisierend oder einschießend,
- begleitende Symptome, z. B. Taubheit, Hyperalgesie, veränderte Sensitivität, Müdigkeit, Schwitzen, Erbrechen und Schlafstörungen, Angst oder depressive Verstimmungen,
- die Bedeutung, die der Mensch mit Schmerzen dem Schmerzerleben beimisst,
- Schmerz verstärkende und lindernde Faktoren,
- Effekte des Schmerzes auf die Lebensqualität, körperliche Funktionsfähigkeit und soziale Teilhabe,
- Schmerzmedikamentengebrauch (dazu zählen auch frei verkäufliche Präparate) sowie
- Stimmungslage.

Sollte das Assessment ergeben, dass Schmerzen vorliegen, ist das Anstreben einer stabilen Schmerzsituation oberstes Gebot. Der Arzt wird unverzüglich informiert, evtl. angesetzte Bedarfsmedikation vollständig ausgeschöpft. Es folgt eine Verlaufskontrolle.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	4	Verw./MA

Sollte in der **Verlaufskontrolle** sichtbar werden, dass die Schmerzen (akut und chronisch) nach

Verabreichung der Bedarfsmedikation und ggf. weiteren nicht-medikamentösen Maßnahmen fortbestehen, ist die Kontaktaufnahme mit dem behandelnden Arzt angezeigt, damit dieser auch in der nachfolgenden Schmerzeinschätzung und -behandlung involviert werden kann.

Eine erneute Einschätzung des Verlaufs durch führen eines Schmerzprotokolls ist engmaschig zu planen und durchzuführen. Das Protokoll sollte immer an den ersten 3 Tagen eines Monats geführt werden. Liegen keine Schmerzen vor, kann es vorerst beendet werden. Treten akut Schmerzen auf ist ebenfalls ein Protokoll zu führen, erneut für 3 Tage.

Die Leitfrage bei der Verlaufskontrolle von Schmerzen sollte sein: „Wie haben sich Schmerzen verändert?“ Dabei kann es zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, z. B.:

- Schmerzen sind nicht mehr vorhanden.
- Schmerzen sind weiterhin vorhanden, die Situation ist stabil, das Schmerzmaß ist für den Menschen mit Schmerzen akzeptabel.
- Schmerzen sind weiterhin vorhanden, die Situation ist instabil, das Schmerzmaß ist für den Menschen mit Schmerzen nicht akzeptabel.

Planung der Maßnahmen

Die Pflegefachkraft plant in Abstimmung mit dem Menschen mit Schmerzen und ggf. seinen Angehörigen, Hausarzt sowie den Mitgliedern des therapeutischen Teams die pflegerischen Anteile eines Schmerzmanagements und beteiligt sich aktiv an der Erstellung eines individuellen Behandlungsplanes. Dabei werden gemeinsam mit dem Menschen mit Schmerzen und ggf. seinen Angehörigen, insbesondere nichtauskunftsfähigen Menschen, individuelle Therapieziele festgelegt, um eine Schmerzsituation stabil zu erhalten oder eine instabile Schmerzsituation zu stabilisieren.

Nur durch die gemeinsame Entscheidungsfindung zwischen dem Menschen mit Schmerzen und der zuständigen Pflegefachkraft sowie weiteren Mitgliedern des Behandlungsteams können Ziele und angestrebte Verbesserungen aufgezeigt und somit eine stabile Schmerzsituation definiert werden. Gemeinsam mit dem interprofessionellen Team werden realistische Ziele abgestimmt. Sowohl dem Menschen mit Schmerzen und ggf. seinen Angehörigen als auch allen am Schmerzmanagement beteiligten Berufsgruppen wird die Möglichkeit gegeben, Einsicht in den Behandlungsplan zu nehmen.

Bestandteile des Behandlungsplanungsplanes:

- Nicht-medikamentöse Maßnahmen
- Medikamentöse Maßnahmen
- Schmerzlindernde Faktoren
- Vermeidung von Schmerz verstärkenden Faktoren
- Schmerz stabilisierende Faktoren
- Unterstützung bei der psychischen Belastung
- Unterstützung bei dem Alltag beeinflussende Schmerzen
- Aktivierungsmaßnahmen
- Schulungsmaßnahmen (auch der Angehörigen)

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	5	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle GmbH	Standard Schmerzmanagement	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Therapie (nur das eine stattfindet, Inhalt plant der Therapeut)

Nicht medikamentöse Maßnahmen können sein

- biologischen Faktoren (z. B. pathophysiologische Veränderungen oder genetische Prädisposition),
- psychischen Faktoren (z. B. Gefühle oder Stressbewältigungsstrategien)
- sozialen Faktoren (z. B. soziale Kontakte oder Beziehungen)
- Wärme
- Kälte
- Ablenkung
- Entspannung

Dieser Behandlungsplan wird zielgruppenspezifisch mit dem Bewohner und/oder seinen Angehörigen besprochen. Die Pflegefachkraft kann dazu Beratungsprotokolle sowie den Expertenstandard nutzen.

Eine Evaluation findet bei Veränderung bzw. der Evaluation des gesamten Pflegeprozesses statt.

Gründe für Anlass bezogene Evaluation:

- wenn eine sich verändernde Schmerzsituation kommuniziert wird, z. B. verbal, nonverbal oder durch Angehörige,
- bei Veränderungen der Therapie, insbesondere Reduktion der medikamentösen Schmerztherapie, z. B. einer Senkung der Dosis der Medikation,
- bei ungewohnt häufiger Einforderung bzw. Applikationsnotwendigkeit kurzfristiger Interventionen zur Schmerzlinderung, z. B. Bedarfsmedikation oder nicht-medikamentöse Maßnahmen,

in Bezug auf chronische Schmerzen sollten folgende Situationen besonders berücksichtigt werden:

- bei Krankheitsfortschritt einer schmerzverursachende Erkrankung, z. B. Tumoren, auch wenn dieser sich noch nicht durch manifeste zusätzliche Schmerzen bemerkbar macht,
- bei einmaligen oder kurzfristigen gesundheitlichen Interventionen, wie z. B. Operationen und größeren diagnostischen Eingriffen oder Übergängen in der Versorgung,
- bei Veränderung der langfristigen Lebensumstände des Betroffenen, z. B. Umzug in ein Pflegeheim oder Hospiz oder Wechsel der Hauptbezugsperson im Sinne von kritischen Lebensereignissen.

Die Pflegefachkraft evaluiert das Schmerzmanagement gemeinsam mit dem Menschen und/oder seinen Angehörigen. Themen können sein:

- Wie stellt sich die aktuelle Schmerzsituation dar: Schmerzintensität, Schmerzqualität, zeitlicher Verlauf, Lokalisation, bisherige Behandlung und Zufriedenheit mit der Schmerzsituation?

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	6	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Standard Schmerzmanagement	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Wie gestalten sich im Alltag aktuell die Lebensqualität, die soziale Teilhabe, die Funktionsfähigkeit, sowie die psychische Belastbarkeit/Stimmung?
- Liegen Beeinträchtigungen durch die Schmerztherapie und Nebenwirkungen vor?
- Konnte die individuelle Zielsetzung im Schmerzmanagement, die gemeinsam mit den Betroffenen und der Pflegefachkraft vereinbart wurden, erreicht werden? Wenn nein, warum nicht?
- Worin bestehen Ziele des Schmerzmanagements, die bis zur nächsten Überprüfung der Wirksamkeit und Zielerreichung erreicht werden sollen?
- Welche Veränderungen im Selbstmanagement der Betroffenen und im individuellen Behandlungsplan sollten vorgenommen werden?

Vorgeschlagene Leitfragen:

Das gemeinsame Besprechen von evtl. notwendigen Anpassungen:

- des individuellen Behandlungsplans,
- des Selbstmanagements des Menschen mit Schmerzen sowie der kurzfristig wirksamen Maßnahmen zur Schmerzlinderung, z. B. bei der Bedarfsmedikation oder der nicht-medikamentösen Schmerztherapie.

Insbesondere bei chronischen Schmerzen sollten zusätzlich folgende Punkte berücksichtigt werden:

- Das Erfassen der aktuellen Lebensqualität in Bezug auf die soziale Teilhabe, die Funktionsfähigkeit sowie die psychische Belastbarkeit/Stimmung,
- Das Erfassen des individuellen Fortschritts in Bezug auf die Ziele, welche der Mensch mit Schmerzen gemeinsam mit der Pflegefachkraft im Rahmen des Schmerzmanagements vereinbart hat,
- Das Vereinbaren neuer Ziele, welche bis zur nächsten Überprüfung der Wirksamkeit und Zielerreichung erreicht werden sollen,
- Das Überprüfen der „individuellen Interventionsgrenze“ für kurzfristig anzuwendende schmerzlindernde Maßnahmen und eventuell beeinflussende Faktoren,

Für das Beurteilen der Stabilität einer Schmerzsituation können folgende Fragen hilfreich sein:

- Gibt es Anzeichen für aktuelle oder zu erwartende Komplikationen (z. B. einen aktuellen oder zu erwartenden, schmerzverursachenden Krankheitsfortschritt)?
- Gibt es Veränderungen im Rahmen von psychosozialen Faktoren (z. B. Tod eines Familienmitgliedes, Verlust der Arbeitsstelle)?
- Bei einer stabilen Schmerzsituation besteht die Möglichkeit, therapeutische Maßnahmen zu reduzieren oder zu ändern.

Die hier aufgeführten Punkte dienen als Orientierung, sie sind jedoch nicht als abschließend zu betrachten.

Verantwortlich für Schulung der Mitarbeiter und Bereitstellung von Schulungsmaterial

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	7	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Standard Schmerzmanagement	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Die Einrichtung

Verantwortlich für den pflegerischen Gesamtprozess

- Pflegedienstleitung

Verantwortlich für die Erstellung, Koordination und Evaluation

- Pflegefachkraft

Verantwortlich für die Durchführung der Maßnahmen:

- Je nach Definition der Pflegefachkraft
 - Pflegefachkräfte
 - Pflegekräfte

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	30.03.2023		1	8	Verw./MA